

1 膵がんの薬薬連携 — 膵酵素・疼痛・黄疸

病院薬剤師	病院と共有する情報	保険薬局薬剤師
① 全身状態・gBRCA・UGT1A1とレジメンの整合性の監査	胆道ステントの有無 (胆管炎のリスク)	① 膵酵素製剤の服用タイミング・量と脂肪便・体重の確認
② FOLFIRINOXの減量(modified)とG-CSF予防の設定	膵酵素製剤の量 (脂肪便・体重)	② オピオイドのレスキュー回数・便秘・眠気の確認
③ 疼痛・胆管炎など症状悪化時の院内連携(緩和ケア・消化器)	疼痛とレスキュー (オピオイド)	③ 電話フォローで発熱・寒気・黄疸・下痢を確認
④ 携帯型ポンプの準備と外来化学療法室での説明	gBRCA (オラパリブ維持療法)	④ 他院の睡眠薬・市販薬を含めた併用薬の確認
⑤ 胆道ステントの有無と胆管炎時の受診先を薬局へ伝達		⑤ オラパリブ維持療法の貧血(検査値)とCYP3A阻害薬を確認

2 主なレジメン・経口薬と薬局での確認ポイント

modified FOLFIRINOX 点滴・注射	オキサリプラチン+イリノテカン+レボホリナート →5-FU 46時間持続静注(急速静注は省略)	2週毎	✓ 携帯型ポンプ ✓ G-CSF予防 ✓ UGT1A1 ✓ 下痢・しびれ
GEM+nab-PTX 点滴・注射	ゲムシタビン+ナブパクリタキセル1・8・15日目	4週毎	✓ 骨髄抑制 ✓ 末梢神経障害 ✓ 脱毛 ✓ 発熱
ゲムシタビン単剤 点滴・注射	1・8・15日目	4週毎	✓ 投与当日～翌日の発熱・倦怠感 ✓ 骨髄抑制 ✓ 間質性肺炎
S-1単剤 経口	4週服用・2週休業(術後補助は6か月)	6週毎	✓ 腎機能に応じた用量 ✓ 下痢・口内炎 ✓ 他のフッ化ピリミジン系は併用禁忌
nal-IRI+5-FU/LV 点滴・注射	イリノテカンリボソーム製剤+レボホリナート+5-FU 46時間	2週毎	✓ 遅発性下痢 ✓ 好中球減少 ✓ UGT1A1
オラパリブ 経口	300mg 1日2回 連日内服(維持療法)	連日	✓ 貧血(定期的な血液検査) ✓ 悪心 ✓ CYP3A阻害薬・誘導薬

● 経口 ● 点滴・注射 ● 点滴+経口 経口薬は保険薬局で交付:服用日・休業日と自宅での副作用を確認

3 相互作用・併用注意(他院処方・市販薬・サプリを含む)

重要度	薬剤(機序)	相手の薬(区分)	起こること	薬局での対応
禁忌 添付文書 併用禁忌	S-1 DPD阻害(ギメラシル)	処方薬 他のフッ化ピリミジン系(カベシタビン・5-FU等)	5-FU濃度↑ → 重篤な骨髄抑制・下痢	切り替え時は7日以上空ける
注意 添付文書 併用注意	S-1 CYP2C9の抑制	処方薬 ワルファリン・フェニトイン	INR↑(出血)・フェニトイン中毒	INR測定の頻度を処方医と確認
注意 添付文書 併用注意	エルロチニブ(ゲムシタビン併用) 胃内pH上昇・CYP1A2誘導	処方薬 市販薬 生活習慣 PPI・H2ブロッカー・喫煙	血中濃度↓ → 効果減弱	市販の胃薬と喫煙状況を確認
注意 添付文書 併用注意	オラパリブ CYP3A阻害・誘導	処方薬 クラリスロマイシン・アゾール系・リファンピシン	副作用↑・効果↓	他院の抗菌薬・抗真菌薬・抗結核薬を確認
注意 添付文書 併用注意	オピオイド 中枢抑制の重複	処方薬 睡眠薬・抗不安薬(他院処方)	過鎮静・呼吸抑制・転倒	他院の睡眠薬・抗不安薬を確認
確認 服薬指導上の注意	オピオイド 便秘対策の不足	市販薬 下剤の自己中断・市販の刺激性下剤	便秘の遷延・腸閉塞	下剤の処方と市販薬の使用状況を確認

4 服薬指導タイムライン — 膵がんの治療に合わせて

① 治療開始前	② 投与後～5日	③ オピオイド開始時	④ オラパリブ維持療法
“消化酵素のお薬は食事のすぐ後に飲むと、脂っぽい便や体重減少を防ぎやすくなります”	“下痢止めや吐き気止めは指示どおりに。ゲムシタビン後の発熱は一時的なことが多いですが、続く時は連絡を”	“痛み止めを始める便秘になりやすいので、下剤と一緒に使しましょう。眠気が強い時は教えてください”	“だるさや息切れは貧血のサインのことがあります。気になる時は教えてください”
✓ 薬局で確認 お薬手帳で全身状態・gBRCA・UGT1A1、胆道ステントの有無	✓ 薬局で確認 電話フォローで下痢・水分量、携帯型ポンプの抜針、G-CSFの予定	✓ 薬局で確認 レスキューの回数と効果、便通、眠気	✓ 薬局で確認 処方箋の検査値でヘモグロビン、CYP3A阻害薬の併用
△ ここに注意 皮膚や白目が黄色い(黄疸)時は至急連絡	△ ここに注意 水様便が止まらない・水分がとれない時は至急連絡	△ ここに注意 3日以上便が出ない・腹痛や嘔吐を伴う時は連絡	△ ここに注意 貧血・血球減少が続く時は処方医へ連絡